

КЛИНИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Инсульты вертебробазилярного бассейна

Почему задний инсульт чаще пропускают: «5 D», центральное головокружение, стволовые синдромы и базилярная катастрофа

Задний бассейн кровоснабжения: ствол, мозжечок, таламус, затылочные доли.
Атипичные и «немоторные» презентации, ограничения догоспитальных шкал,
дифференциальный диагноз с периферическим головокружением.
Серия «Крещение поворотом» · версия 2.0 · 19 августа 2026 · CC BY-NC-SA 4.0

Клинический случай

Слово бригаде

“Вызов к мужчине 63 лет, повод — «головокружение, рвота». Вызывала жена: муж встал из-за стола, его «повело» влево, он уцепился за стену, сел на пол и дальше встать не смог. В анамнезе гипертоническая болезнь, курит; два дня назад был короткий эпизод головокружения с двоением, прошёл сам за полчаса, никуда не обращался.

На месте: сидит на полу, держится за мебель, в сознании, ориентирован, жалуется на вращение окружающего и тошноту, рвало три раза. Попытка поставить его на ноги не удалась: без поддержки с двух сторон не стоит, ведёт влево. Головной боли нет, но есть неприятное ощущение в шее слева, появившееся в тот же день. Жена добавляет, что муж поперхнулся водой, когда она попыталась его напоить, и «голос стал другой».

Объективно: артериальное давление 165/95 мм рт. ст., пульс 78 в минуту, ритмичный, SpO₂ 97 %, глюкоза 6,1 ммоль/л, температура 36,7 °C, на ЭКГ синусовый ритм без острых изменений. Сила в руках и ногах сохранена, проба Барре отрицательна, асимметрии угла рта нет, речь по содержанию правильная. По шкале LAMS — 0 баллов.

При целенаправленном осмотре: голос охрипший, артикуляция смазана; горизонтальный нистагм, быстрая фаза меняет направление при перемене направления взора; слева узкий зрачок и опущенное верхнее веко; мягкое нёбо слева поднимается хуже; пальце-носовую пробу левой рукой выполняет с промахом, правой — точно. Укол иглой от шприца ощущает слабее на левой половине лица и на правой половине туловища и конечностей.

На вопрос жены «это ведь уши, ему раньше от шеи так было» бригада ответила, что везёт его в инсультный центр.”

Случай передан коллегами и пересказан от лица бригады, бывшей на вызове.

Разбор случая приведён в конце материала.

Вопросы для размышления

Ответы — в конце материала.

1. Почему стандартные догоспитальные шкалы (FAST, LAMS) занижают тяжесть инсульта вертебробазилярного бассейна и что оценивается дополнительно?
2. Какие симптомы складываются в картину ишемии заднего бассейна и что скрывается за мнемоникой «5 D»?
3. Какие признаки складываются в синдром Валленберга и почему при нём нет пареза?
4. Центральное или периферическое головокружение — что показывает алгоритм HINTS и почему нормальный тест поворота головы тревожнее патологического?
5. Почему улучшение симптомов по дороге в стационар не позволяет успокоиться при подозрении на поражение базилярной артерии?
6. Чем маршрутизация и временные окна при заднем инсульте отличаются от переднего и как дисфагия меняет действия бригады?

Общие положения

Инсульты вертебробазилярного (заднего) бассейна составляют около 20–25 % всех ишемических инсультов. Их принципиальная особенность — высокая частота ошибочной или запоздалой догоспитальной и приёмной диагностики: по данным ряда исследований,

задний инсульт пропускается или диагностируется с опозданием в 2–3 раза чаще переднего.

Причины этого систематического недоучёта:

- симптомы часто неспецифичны и «немоторны»: головокружение, тошнота и рвота, неустойчивость, головная боль, изменение поведения и уровня сознания;
- отсутствие или минимальная выраженность классической триады «лицо – рука – речь», на которую настроены скрининговые шкалы;
- атипичные проявления (изолированное головокружение, зрительные нарушения, спутанность) легко объясняются альтернативными, «доброкачественными» диагнозами — вестибулярной патологией, делирием, интоксикацией, декомпенсацией хронических состояний;
- волнообразное, нарастающее или преходящее течение при тромбозе базилярной артерии, создающее ложное впечатление улучшения.

Цена ошибки при поражении заднего бассейна выше, чем при большинстве передних инсультов: окклюзия базилярной артерии без реперфузии сопровождается летальностью, приближающейся к 80–90 %.

Анатомия заднего бассейна

Задний бассейн формируется двумя позвоночными артериями, которые сливаются в непарную базилярную артерию; та, в свою очередь, делится на задние мозговые артерии.

Артерия	Зона кровоснабжения
Позвоночные артерии (ПА)	Продолговатый мозг, задненижние отделы мозжечка (через ЗНМА)
Задняя нижняя мозжечковая (ЗНМА, PICA)	Латеральный отдел продолговатого мозга, нижняя поверхность мозжечка
Базилярная артерия (БА)	Мост, средний мозг, верхние отделы мозжечка (через ПНМА и ВМА); перфоранты к стволу
Передняя нижняя мозжечковая (ПНМА, AICA)	Латеральный отдел моста, внутреннее ухо (лабиринтная артерия), передненижний мозжечок
Верхняя мозжечковая (ВМА, SCA)	Верхняя поверхность мозжечка, латеральный отдел среднего мозга
Задняя мозговая (ЗМА, PCA)	Затылочная доля (зрительная кора), медиобазальные отделы височной доли, таламус (перфоранты), средний мозг

Из этой анатомии следует ключевая особенность заднего инсульта: в пределах небольшого объёма ствола плотно упакованы черепные ядра, проводящие двигательные и чувствительные пути, мозжечковые связи, центры зрения, дыхания и кровообращения, восходящая активирующая система. Поэтому клиника заднего инсульта разнообразна, часто двусторонняя и нередко минует конечности.

Клиническая картина: «5 D» и не только

Классическая мнемоника ишемии заднего бассейна — «5 D»:

Признак	Содержание
Dizziness — головокружение	Системное (вращательное) или несистемное, часто с тошнотой и рвотой
Diplopia — двоение	Поражение ядер и путей глазодвигательных нервов, центров взора
Dysarthria — дизартрия	Нарушение артикуляции (в отличие от афазии — расстройства языка)
Dysphagia — дисфагия	Поражение каудальной группы черепных нервов (IX, X)
Dystaxia — атаксия	Мозжечковая или сенситивная; неустойчивость при стоянии и ходьбе

Ряд авторов расширяет перечень до «drop attacks» (внезапные падения без утраты сознания) и «deafness» (острое снижение слуха при поражении ПНМА).

Дополнительные проявления, не входящие в мнемонику, но принципиальные:

- **зрительные нарушения:** гомонимная гемианопсия, корковая слепота (при двустороннем поражении затылочных долей — вплоть до синдрома Антона с анозогнозией слепоты);
- **изменение уровня сознания и поведения:** оглушение, спутанность, агитация, апатия — при поражении таламуса и восходящей активирующей системы ствола;
- **нарушения речи по типу афазии** при вовлечении таламуса или височно-затылочных отделов (таламическая афазия, парафазии) — **редкий вариант**, а не опорный признак: в мнемонике «5 D» стоит дизартрия, а не афазия, и беглая афазия с парафазиями гораздо чаще указывает на передний бассейн (нижнюю ветвь средней мозговой артерии);
- **альтернирующие стволые синдромы:** черепной нерв на стороне очага + проводниковые расстройства на противоположной стороне (см. ниже);
- **вегетативная и дыхательная нестабильность** при поражении продолговатого мозга.

Красные флаги: центральное против периферического головокружения

Наибольшую диагностическую трудность представляет остро возникшее изолированное головокружение: оно свойственно как доброкачественной вестибулярной патологии, так и инфаркту мозжечка или ствола (ЗНМА, ПНМА). Ориентиры, смещающие вероятность в сторону центрального (мозгового) генеза:

- невозможность самостоятельно стоять и идти (выраженная туловищная атаксия) — при периферическом головокружении пациент, как правило, ходит, хотя и с отклонением;
- сопутствующие очаговые знаки: дизартрия, дисфагия, диплопия, асимметрия лица, перекрёстные чувствительные расстройства, синдром Горнера;
- впервые возникшая интенсивная головная боль или боль в шее (риск диссекции позвоночной артерии, особенно у пациентов молодого и среднего возраста);
- нистагм, меняющий направление при перемене направления взора, либо вертикальный нистагм;
- отсутствие типичной позиционной провокации и истощаемости, характерных для доброкачественного позиционного головокружения.

Алгоритм HINTS

При остром вестибулярном синдроме (продолжающееся головокружение с нистагмом, тошнотой, неустойчивостью) применяется трёхкомпонентная оценка HINTS: **H**ead **I**mpulse — **N**ystagmus — **T**est of **S**kew.

Компонент	Как выполняется	Периферическое поражение	Центральное поражение (инсульт)
Тест поворота головы (head impulse)	Пациент фиксирует взгляд на переносице исследователя; голова пассивно и быстро поворачивается на 10–20° в сторону, взгляд отслеживается	Патологический: глаза уезжают вместе с головой, затем возвращаются корректирующей саккадой	Нормальный: взгляд удерживается на цели, саккады нет
Нистагм	Оценивается в прямом зоре и при отведении взора вправо и влево не более чем на 30°	Однонаправленный горизонтальный: быстрая фаза всегда в одну сторону, подавляется фиксацией взгляда	Меняющий направление при перемене направления взора, либо вертикальный или торсионный
Тест перекрытия (test of skew)	Пациент смотрит на цель прямо перед собой; заслонка поочередно переносится с одного глаза на другой, открывающийся глаз отслеживается	Вертикального рассогласования глаз нет	Вертикальное корректирующее движение открывающегося глаза — косая девиация (skew)

Техника проб подробнее.

Тест поворота головы (проба Хальмаги). Проверяется вестибулоокулярный рефлекс — контур, удерживающий взгляд на цели при движении головы. Пациент сидит, фиксирует взгляд на переносице исследователя; исследователь удерживает голову руками и делает быстрый пассивный поворот малой амплитуды (10–20°) в одну сторону, затем в другую, каждый раз возвращая голову в исходное положение. Оценивается только одно: остались ли глаза на цели. При вестибулярном неврите рефлекс на стороне поражения выпадает, глаза уезжают вместе с головой и возвращаются на цель заметной догоняющей саккадой — тест патологический, что говорит в пользу периферии. Если при остром вестибулярном синдроме рефлекс сохранён и саккады нет, значит периферический аппарат работает, а причина головокружения лежит выше. Проба не выполняется при подозрении на травму шеи, нестабильность шейного отдела и диссекцию позвоночной артерии.

Нистагм. Направление быстрой фазы оценивается при взгляде прямо и при отведении взора в стороны, не более 30°: при большем отведении появляется физиологический установочный нистагм, который легко принять за патологический. Периферический нистагм горизонтальный, однонаправленный, усиливается при взгляде в сторону быстрой фазы и ослабевает при фиксации взгляда. Смена направления быстрой фазы при перемене направления взора, а также вертикальный или торсионный нистагм периферическим поражением не объясняются.

Тест перекрытия. Ищется косая девиация — вертикальное рассогласование глаз при поражении отолитово-глазных путей ствола. Пациент фиксирует взгляд на цели прямо перед собой; ладонь или заслонка закрывает один глаз на одну-две секунды и переносится на другой, и так несколько раз. Наблюдают за глазом, который открывается: вертикальное корректирующее движение вверх или вниз означает, что под заслонкой глаз отклонялся по вертикали. Горизонтальные движения в этой пробе к HINTS не относятся.

Ключевой и контринтуитивный момент: при остром вестибулярном синдроме **нормальный тест поворота головы указывает на центральное поражение**, а не на благополучие. Отсюда мнемоника опасного результата INFARCT: Impulse Normal — Fast-phase Alternating — Refixation on Cover Test; любой из трёх признаков достаточен для настороженности.

Границы применимости. Алгоритм рассчитан на продолжающееся головокружение с нистагмом и не применяется при эпизодическом позиционном головокружении и при отсутствии нистагма — вне этих условий его результат не интерпретируется. Оценка зависит от опыта исполнителя и не заменяет нейровизуализацию: на догоспитальном этапе HINTS служит основанием для настороженности, а не для исключения инсульта. Расширенный вариант HINTS+ добавляет четвёртый компонент — остро возникшее снижение слуха, которое при остром вестибулярном синдроме говорит в пользу инфаркта в зоне передней нижней мозжечковой артерии, а не в пользу периферического поражения.

Инсульт под маской: спутанность, поведение, «немоторные» дебюты

Остро возникшее изменение поведения и уровня сознания у пожилого пациента закономерно объясняют делирием, деменцией, депрессией, интоксикацией или декомпенсацией соматического заболевания. Поражение заднего бассейна способно воспроизводить каждую из этих картин:

- **двустороннее поражение таламуса** (в том числе при окклюзии артерии Першерона — общего ствола, питающего медиальные отделы обоих таламусов) — угнетение сознания, дезориентация, нарушения памяти, парез вертикального взора;
- **поражение задних мозговых артерий** с вовлечением височно-затылочных отделов — ажитация, спутанность, зрительные нарушения, парафазии;
- **инфаркт мозжечка** — головокружение и рвота, ошибочно трактуемые как гастроэнтерологические или вестибулярные.

Признаки, указывающие на сосудистую природу острого спутанного состояния: внезапное («по минутам») начало, наличие любого очагового знака (асимметрия лица, девиация языка, дизартрия, нистагм, гемианопсия, атаксия), несоответствие картины привычному для пациента уровню и течению хронического заболевания. Делирий, деменция и депрессия не сопровождаются впервые возникшей очаговой неврологической симптоматикой.

Стволовые синдромы

Поражение ствола даёт **альтернирующие синдромы**: на стороне очага — расстройства черепных нервов (их ядра лежат на своём уровне), на противоположной стороне — проводниковые расстройства (двигательные и чувствительные пути перекрещиваются каудальнее). Медиальные очаги захватывают пирамидные пути (есть гемипарез),

латеральные — мозжечковые связи и чувствительные пути (гемипареза нет, есть атаксия).

Средний мозг (общий нерв — III)

Синдром	Локализация	Ипсилатерально (черепной нерв)	Контралатерально (пути)	Артерия
Вебера	Медиальный	III нерв: птоз, мидриаз, расходящееся косоглазие	Гемипарез	ЗМА
Бенедикта	Парамедианный	III нерв	Гемиатаксия, тремор (красное ядро)	ЗМА
Клода	Латеральный	III нерв	Мозжечковая атаксия (без гемипареза)	ВМА
Парино	Дорсальный (крыша)	Парез вертикального взора, нарушение конвергенции, нистагм	—	ЗМА

Мост (общие нервы — VI, VII)

Синдром	Локализация	Ипсилатерально	Контралатерально	Особенность
Мийяра–Гюблера	Медиальный, нижний мост	VII нерв (периферический парез мимики)	Гемипарез	Классический pontинный
Фовилля	Медиальный, каудальнее	VI + VII нервы (парез взора + мимики)	Гемипарез	Глаза «смотрят на парализованные конечности»
Мари–Фуа	Латеральный	V, VII, VIII нервы	Гемиатаксия, чувствительные расстройства	Без гемипареза
Синдром «запертого человека»	Вентральный, двусторонний	Сохранены только вертикальные движения глаз	Тетраплегия, анартрия	Окклюзия базилярной артерии

Продолговатый мозг (общие нервы — IX, X, XII)

Синдром	Локализация	Ипсилатерально	Контралатерально	Артерия
Дежерина (медиальный)	Медиальный	XII нерв: девиация языка в сторону очага	Гемипарез, нарушение глубокой чувствительности	Передняя спинномозговая
Валленберга (латеральный)	Латеральный	V (лицо), IX, X (дисфагия, дисфония), Горнер, вестибулярные ядра, атаксия	Нарушение болевой и температурной чувствительности на теле	ЗНМА или позвоночная

Синдром Валленберга — наиболее частый и клинически показательный: **головокружение, рвота, дисфагия, охриплость, атаксия, синдром Горнера и перекрёстное расстройство чувствительности (лицо на стороне очага, тело — на противоположной) при полностью сохранной силе в конечностях**. Отсутствие пареза — та самая причина, по которой моторные шкалы его не улавливают.

Артерия и синдром

Артерия	Синдромы
Задняя мозговая (ЗМА)	Вебера, Бенедикта, Парино; гемианопсия, корковая слепота, таламические синдромы
Верхняя мозжечковая (ВМА)	Клода; мозжечковая атаксия
Базиллярная (БА)	Понтинные синдромы, «запертый человек», синдром верхушки базиллярной артерии
Передняя нижняя мозжечковая (ПНМА)	Латеральный понтинный синдром, острое снижение слуха и головокружение
Задняя нижняя мозжечковая (ЗНМА)	Валленберга
Передняя спинномозговая	Дежерина

Базиллярная катастрофа: тромбоз и верхушка базиллярной артерии

Окклюзия базиллярной артерии — отдельное, наиболее опасное проявление заднего инсульта. Характерные черты:

- **волнообразное, ступенеобразно нарастающее или преходящее начало:** транзиторные эпизоды дизартрии, диплопии, головокружения, кратковременной слабости или спутанности, предшествующие развёрнутой картине; период мнимого улучшения не исключает продолжающегося тромбоза;
- **прогрессирующее угнетение сознания вплоть до комы;**
- **синдром «запертого человека»:** тетраплегия и анартрия при сохранном сознании и сохраненных вертикальных движениях глаз и моргании — состояние, которое можно ошибочно принять за кому или психическое расстройство;
- **синдром верхушки базиллярной артерии:** сочетание зрительных нарушений, глазодвигательных расстройств (парез вертикального взора, зрачковые аномалии),

нарушений сознания и поведения при вовлечении среднего мозга, таламусов и затылочных долей.

Для базилярной окклюзии временные окна реперфузионной терапии рассматриваются как расширенные по сравнению с типичным передним инсультом: механическая тромбэктомия и тромболизис могут обсуждаться позднее стандартных сроков ввиду фатального прогноза без реперфузии. Практическое следствие для догоспитального этапа — подозрение на базилярную окклюзию является основанием для экстренной доставки в центр с возможностью тромбэктомии, независимо от кажущегося улучшения.

Ограничения догоспитальных шкал

Скрининговые шкалы (FAST, Cincinnati/CPSS, LAMS) построены преимущественно на признаках поражения переднего бассейна — асимметрии лица, слабости и дрейфе руки, нарушении речи. Их чувствительность к заднему инсульту снижена; значительная часть поражений заднего бассейна даёт **низкий или нулевой балл**.

Шкала	На что настроена	Слабое место при заднем инсульте
FAST	Лицо, рука, речь, время	Не оценивает головокружение, атаксию, диплопию, поля зрения, дисфагию
LAMS	Асимметрия лица, дрейф руки, сила кисти (0–5)	«Немоторный» задний инсульт набирает 0–1 балл; низкий балл не исключает поражения
CPSS	Лицо, рука, речь	Те же ограничения, что у FAST

Низкий балл по моторной шкале при наличии остро возникших головокружения, атаксии, диплопии, дизартрии, зрительных или поведенческих нарушений не исключает инсульта. Дополнительно к шкале целенаправленно оцениваются: походка и способность стоять, координаторные пробы, движения глаз и наличие нистагма, поля зрения, симметрия мягкого нёба и языка, глотание, речь (дизартрия и афазия).

Догоспитальная тактика

Общий принцип — задний инсульт ведётся по тому же алгоритму острого нарушения мозгового кровообращения, что и передний, с поправкой на его коварство при оценке тяжести и на приоритет доставки в центр с реперфузионными возможностями.

Мероприятие	Объём
Время начала	Устанавливается точное время появления симптомов или время, когда пациента последний раз видели здоровым; фиксируется как ключевой параметр для стационара
Дыхательные пути и дыхание	Контроль проходимости (риск аспирации при дисфагии и угнетении сознания); оксигенотерапия при SpO ₂ ниже целевого уровня по алгоритму
Гемодинамика	Артериальное давление рутинно не снижается; коррекция — только при значениях и показаниях, оговорённых действующим алгоритмом ОНМК
Глюкоза крови	Обязательное измерение: гипогликемия воспроизводит очаговую симптоматику и подлежит немедленной коррекции
Позиционирование	По уровню сознания и риску аспирации; при угнетении сознания и рвоте — устойчивое боковое положение
Оценка тяжести	Догоспитальная шкала дополняется прицельной оценкой стволовых и мозжечковых знаков
Маршрутизация	Экстренная доставка в стационар с возможностью тромболизиса и тромбэктомии, с предварительным оповещением
Что не выполняется	Пероральный приём пищи, воды и препаратов при дисфагии и угнетённом сознании; антикоагулянты и антиагреганты на догоспитальном этапе не вводятся

Транзиторная ишемическая атака заднего бассейна

Полный регресс симптоматики (в том числе по дороге в стационар) не снимает диагноза и не снижает срочности. Преходящие эпизоды дизартрии, диплопии, головокружения, атаксии или спутанности могут быть предвестниками тромбоза базилярной артерии; «улучшение» при этом отражает не разрешение процесса, а его волнообразное течение.

Транзиторная ишемическая атака — маркер высокого риска инсульта в ближайшие часы и дни и является показанием к экстренной госпитализации и обследованию, а не к оставлению пациента на месте. Регресс симптомов на догоспитальном этапе фиксируется в документации вместе с описанием исходной картины: именно исходная картина, а не состояние на момент передачи, определяет объём обследования в стационаре.

Риск в цифрах, отличие от мигренозной ауры, приступа и синкопе, шкала ABCD² и различие в активе при отказе от эвакуации разобраны в отдельном материале серии — «Транзиторная ишемическая атака».

Возвращение к клиническому случаю

Ноль баллов по LAMS при очевидном инсульте. Шкала оценила три вещи: асимметрию лица, дрейф руки, силу кисти — и все три оказались сохранены. Очаг же затронул латеральные отделы продолговатого мозга, где пирамидного пути нет. Если

остановиться на шкале, вызов закрывается диагнозом «вестибулопатия» и рекомендацией обратиться в поликлинику.

Невозможность стоять — самый доступный признак. Пациент не стоит без поддержки с двух сторон. При периферическом головокружении больной, как правило, ходит — плохо, с отклонением, но ходит. Выраженная туловищная атаксия требует одного действия — попробовать поставить пациента на ноги, а не оценивать его сидя.

Осмотр собрал синдром Валленберга. На стороне очага (слева): синдром Горнера — узкий зрачок и опущенное веко (нисходящие симпатические волокна), снижение болевой чувствительности на лице (спинальное ядро V нерва), охриплость, поперхивание и отставание мягкого нёба (IX и X нервы), мозжечковая атаксия в левой руке, головокружение и нистагм (вестибулярные ядра). На противоположной стороне — снижение болевой чувствительности на теле и конечностях (спиноталамический путь). Перекрёстное расстройство чувствительности — лицо слева, туловище справа — вне ствола не воспроизводится. Пареза при этом нет и быть не должно: очаг латеральный.

Нистагм, меняющий направление. Смена направления быстрой фазы при перемене направления взгляда периферическим поражением не объясняется. Вместе с очаговыми знаками этого достаточно для центральной трактовки; проба Хальмаги в данном случае не выполнялась и выполняться не должна — боль в шее делает вероятной диссекцию позвоночной артерии, а при подозрении на диссекцию быстрые пассивные повороты головы противопоказаны.

Боль в шее и возраст. Боль в шее слева, появившаяся в тот же день, при инфаркте в бассейне задней нижней мозжечковой артерии — аргумент за диссекцию позвоночной артерии как причину. Диссекция типичнее для молодых и средних возрастов, но возрастом шестьдесят три года она не исключается; атеротромбоз и кардиоэмболия остаются в том же ряду. На тактику бригады это не влияет, но обязательно звучит в передаче в стационаре.

Эпизод двумя днями ранее. Короткий самостоятельно разрешившийся эпизод головокружения с двоением — транзиторная ишемическая атака в том же бассейне, то есть предупреждение, которое не было услышано. Собирать такие эпизоды надо целенаправленным вопросом: сами о них не рассказывают, потому что «всё же прошло». Подробно о цене такого эпизода — в материале серии «Транзиторная ишемическая атака».

Дисфагия меняет действия, а не только диагноз. Охриплость, поперхивание и асимметрия нёба означают риск аспирации: внутрь ничего не даётся, транспортировка на носилках с готовностью к санации, при рвоте и угнетённом сознании — устойчивое боковое положение.

Давление 165/95 мм рт. ст. не снижается. Порог для урапидила при инсульте и инфаркте мозга — систолическое давление выше 200 мм рт. ст.; при субарахноидальном и внутримозговом кровоизлиянии — выше 180 мм рт. ст. Здесь не достигнут ни один из них.

Исход. Пациент доставлен в инсультный центр с предварительным оповещением. По данным, которые бригада узнала впоследствии, подтверждён инфаркт латеральных отделов продолговатого мозга; глотание восстанавливалось постепенно, первые сутки питание шло через зонд.

Главный вывод случая. Диагноз дали не шкала и не повод к вызову, а четыре действия, каждое из которых занимает полминуты и не требует ничего, кроме рук и голоса: попробовать поставить на ноги, посмотреть нистагм в трёх направлениях взгляда, послушать голос и посмотреть нёбо, сравнить болевую чувствительность на лице и на теле.

Резюме

- Инсульт заднего бассейна пропускается в несколько раз чаще переднего из-за неспецифичных и «немоторных» симптомов и слабой чувствительности скрининговых шкал.
- Ядро клинической картины — «5 D»: головокружение, диплопия, дизартрия, дисфагия, атаксия; дополнительно — зрительные нарушения, изменение сознания и поведения, альтернирующие стволовые синдромы.
- Остро возникшая спутанность у пожилого пациента требует исключения инсульта; отличие от делирия, деменции и депрессии — внезапное начало и наличие очаговой симптоматики. Афазия при заднем инсульте — редкий вариант (таламус, височно-затылочная область); чаще она указывает на передний бассейн.
- Синдром Валленберга — головокружение, рвота, дисфагия, охриплость, атаксия, синдром Горнера и перекрёстное расстройство чувствительности при полностью сохранной силе в конечностях, то есть 0 баллов по LAMS.
- При остром изолированном головокружении центральную природу поддерживают невозможность стоять и идти, очаговые знаки, головная или шейная боль, направление-меняющий или вертикальный нистагм; при HINTS нормальный тест поворота головы указывает на инсульт.
- Низкий балл по моторной шкале (FAST, LAMS) не исключает заднего инсульта; оценка дополняется походкой, координацией, движениями глаз, полями зрения, глотанием и речью.
- Оклюзия базилярной артерии протекает волнообразно и фатальна без реперфузии; временные окна реперфузии при ней расширены, поэтому подозрение — основание для доставки в центр с тромбэктомией независимо от кажущегося улучшения.
- Полный регресс симптомов, в том числе по дороге, не снимает диагноз транзиторной ишемической атаки и не снижает срочности госпитализации.

Ответы на вопросы для размышления

1. Шкалы FAST, LAMS и CPSS настроены на признаки переднего бассейна — асимметрию лица, слабость и дрейф руки, нарушение речи. Задний инсульт часто «немоторный» и набирает 0–1 балл. Дополнительно оцениваются походка и способность стоять, координаторные пробы, движения глаз и нистагм, поля зрения, симметрия нёба и языка, глотание, наличие дизартрии и афазии.
2. «5 D» — Dizziness (головокружение), Diplopia (двоение), Dysarthria (дизартрия), Dysphagia (дисфагия), Dystaxia (атаксия). Расширенно добавляют drop attacks (внезапные падения) и deafness (острое снижение слуха). Вне мнемоники значимы также гомонимная гемианопсия и корковая слепота, изменение сознания и поведения, афазия при вовлечении таламуса, альтернирующие стволовые синдромы.
3. Синдром Валленберга — поражение латеральных отделов продолговатого мозга (ЗНМА или позвоночная артерия). На стороне очага: синдром Горнера (узкий зрачок, опущенное веко), снижение болевой и температурной чувствительности на лице (спинальное ядро V), дисфагия, дисфония и отставание мягкого нёба (IX, X), головокружение, рвота и нистагм (вестибулярные ядра), мозжечковая атаксия. На противоположной стороне — снижение болевой и температурной чувствительности на теле (спиноталамический путь). Пареза нет, потому что пирамидный путь лежит медиально и в зону латерального инфаркта не попадает; именно поэтому моторные шкалы дают ноль баллов.
4. HINTS (Head Impulse — Nystagmus — Test of Skew) применяется при остром вестибулярном синдроме с нистагмом. Тест поворота головы: пациент фиксирует взгляд

на переносице исследователя, голова быстро пассивно поворачивается на 10–20°, оценивается удержание взгляда на цели. Нистагм оценивается прямо и при отведении взора не более чем на 30°. Тест перекрытия: заслонка поочерёдно переносится с одного глаза на другой, отслеживается вертикальное корректирующее движение открывающегося глаза. На центральное поражение указывают: нормальный тест поворота головы (нет корректирующей саккады), нистагм, меняющий направление, или вертикальный нистагм, и косая девиация при тесте перекрытия. Нормальный тест поворота головы тревожнее патологического, потому что при истинном периферическом поражении вестибулоокулярный рефлекс нарушен и саккада появляется; её отсутствие означает, что периферия сохранна, а причина — центральная.

5. При тромбозе базилярной артерии течение волнообразное: эпизоды дизартрии, диплопии, головокружения и спутанности сменяются мнимым улучшением, которое отражает не разрешение, а динамику тромбоза. Преходящий эпизод в заднем бассейне — предвестник базилярной окклюзии, фатальной без реперфузии, поэтому регресс симптомов срочности не снижает.

6. Задний инсульт ведётся по общему алгоритму ОНМК, но подозрение на окклюзию базилярной артерии требует доставки в центр с возможностью тромбэктомии; временные окна реперфузии при базилярной окклюзии рассматриваются как расширенные по сравнению с типичным передним инсультом. Исходная (а не «улучшившаяся») картина и точное время начала определяют объём помощи в стационаре. Выявленная дисфагия меняет действия на месте: внутрь не даётся ни вода, ни препараты, транспортировка на носилках с готовностью к санации, при рвоте и угнетённом сознании — устойчивое боковое положение.

Источники

- Алгоритмы оказания скорой и неотложной медицинской помощи. Приказ ДЗМ г. Москвы № 535 от 18.05.2023, раздел «Неврология», острое нарушение мозгового кровообращения.
- Caplan L. R. Posterior Circulation Ischemia: Vertebrobasilar Disease. — обзор клиники и синдромов заднего бассейна.
- Kattah J. C. et al. HINTS to diagnose stroke in the acute vestibular syndrome. *Stroke*, 2009.
- Oxford Handbook of Emergency Medicine — stroke, posterior circulation, acute vertigo.
- Tintinalli's Emergency Medicine: A Comprehensive Study Guide — ischemic stroke, brainstem and cerebellar syndromes.
- Верткин А. Л. Скорая медицинская помощь: руководство для фельдшеров и врачей.

Выходные данные

Материал: «Инсульты вертебробазилярного бассейна». Версия 2.0 от 19 августа 2026. Клинический случай заменён на случай латерального инфаркта продолговатого мозга (синдром Валленберга) с разбором и исходом; прежний случай перенесён в материал «Транзиторная ишемическая атака». Пересмотрены вопросы для размышления и ответы, уточнено место афазии в клинике заднего бассейна.

Серия: «Крещение поворотом» — клинические разборы догоспитальной практики.

Лицензия: текст — Creative Commons «С указанием авторства — Некоммерческая — С сохранением условий» 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0). Копировать, печатать и раздавать коллегам можно свободно, включая печать для подстанции; продавать — нельзя; при переработке сохраняется та же лицензия и указывается источник.

Оговорка. Материал учебный. Он не является нормативным документом, не заменяет действующие протоколы, клинические рекомендации и распоряжения службы и не может использоваться как единственное основание для клинического решения. Дозы, показания и маршрутизацию проверять по первоисточникам, действующим на момент чтения. Ответственность за решения у постели больного несёт медицинский работник, а не автор материала.

О клиническом случае. Случай передан коллегами, рассказан от лица бригады и обезличен: нет имени, даты вызова, адреса, номера карты вызова, номера бригады и названия стационара, бытовые детали изменены. Совпадения с чужой практикой возможны и неизбежны: такие вызовы происходят ежедневно.

Нашли ошибку? Ошибка в дозе, сроке или механизме — не мелочь: материал читают перед сменой. Сообщить можно через раздел Issues репозитория проекта; исправление выходит новой версией, а изменение фиксируется в журнале изменений.